Acelerador de Clínicas

COLEÇÃO ACELERADOR DE CLÍNICAS · VOLUME 06

MÉTODO RESGATE

Resgate de Ouro

Como reativar pacientes que sumiram e fazer a clínica crescer com quem já confiou em você — com ética e sem parecer vendedor.

PROPOSTA ÚNICA DE VALOR

A receita mais rápida e barata da sua clínica já está no seu prontuário: um método em sete passos para mapear, entender, segmentar e reabordar pacientes inativos com cuidado ativo — gerando retornos, continuidade de tratamento e indicações sem gastar um real a mais em anúncios.

Uma metodologia **Acelerador de Clínicas**

aceleradordeclinicas.com.br

ANTES DE COMEÇAR

Por que este e-book existe

Toda clínica perde pacientes no caminho — mesmo entregando um atendimento técnico impecável. Gente que fez a primeira consulta e não voltou, que começou um tratamento e parou, que deveria estar em acompanhamento e simplesmente sumiu. Na maioria das vezes, o problema não está na consulta: está na falta de um processo para reencontrar essas pessoas.

Enquanto isso, a clínica corre atrás de pacientes novos, que custam caro e ainda não confiam nela. É um paradoxo: o paciente mais fácil de atender é o que já conhece o profissional, a estrutura e o jeito de cuidar — e é justamente o mais esquecido.

Este volume entrega um método simples, aplicável e ético para olhar com estratégia para o que a clínica já tem. Antes de buscar novos pacientes, fortaleça quem já confiou em você um dia.

A PROMESSA DESTE VOLUME (PUV)

A receita mais rápida e barata da sua clínica já está no seu prontuário: um método em sete passos para mapear, entender, segmentar e reabordar pacientes inativos com cuidado ativo — gerando retornos, continuidade de tratamento e indicações sem gastar um real a mais em anúncios.

O que torna este método único: o RESGATE trata reativação como cuidado, não como cobrança. Ele começa pela causa do afastamento (medo, falta de orientação, custo ou sensação de alta), segmenta a base por temperatura e só então escolhe a proposta, o canal, quem fala e o roteiro — fechando com indicadores de retorno e de impacto financeiro.

PARA QUEM É

- ✔ Clínicas com prontuário cheio e agenda com buracos
- ✔ Quem quer crescer sem aumentar o investimento em marketing
- ✔ Tratamentos com várias sessões ou acompanhamento contínuo
- ✔ Equipes que nunca fizeram reabordagem por medo de “incomodar”

O QUE VOCÊ CONQUISTA

- → Uma lista viva de pacientes a reativar, organizada por prioridade
- → Hipóteses claras sobre por que cada perfil se afastou
- → Propostas personalizadas e roteiros prontos por situação
- → Um calendário de relacionamento que evita novos sumiços
- → Indicadores de retorno e de impacto financeiro da reativação

DIAGNÓSTICO RÁPIDO · 3 MINUTOS

Onde sua clínica está hoje

Marque cada afirmação verdadeira. Cada marcação vale 1 ponto. A pontuação diz por onde começar — e o que ainda não adianta fazer.

- [ ] Sei quantos pacientes fizeram a primeira consulta e não voltaram nos últimos 12 meses.
- [ ] Sei quantos pacientes interromperam um tratamento antes do fim.
- [ ] Temos uma lista de pacientes que deveriam estar em acompanhamento e não estão.
- [ ] Registramos no prontuário o motivo provável de cada afastamento.
- [ ] Temos roteiros de reabordagem diferentes para cada situação.
- [ ] Está definido quem faz a reabordagem: profissional, secretária ou CRC.
- [ ] Fazemos pelo menos uma ação de reativação por mês.
- [ ] Temos um calendário de contatos de relacionamento (pós-consulta, datas especiais, lembretes).
- [ ] Medimos quantos pacientes reabordados retornam.
- [ ] Sabemos quanto faturamos com pacientes reativados.

0–3 **Ouro enterrado**
Há dinheiro parado no prontuário. Comece por R e E nesta semana.

4–6 **Ações isoladas**
Já existem tentativas, falta método. Foque em S, G e A.

7–8 **Resgate em andamento**
Falta transformar em rotina. Vá para T e E (eternizar).

9–10 **Base viva**
Reativação é processo. Use os números para metas mensais.

LINHA DE RACIOCÍNIO

A lógica por trás do método

Antes da técnica, o porquê. Se você entender esta sequência, consegue adaptar o método a qualquer especialidade, tamanho de equipe ou cidade.

1. **Não dá para recuperar quem você nem sabe que sumiu**
   O primeiro problema da maioria das clínicas não é a abordagem — é a ausência de uma lista. Sem mapeamento, a reativação depende da memória de alguém.

2. **Todo afastamento tem um motivo**
   Os mais comuns são medo, falta de orientação clara, custo e a sensação de que "já está bom". Cada motivo pede uma resposta diferente, e o prontuário costuma dar as pistas.

3. **Proposta genérica soa como venda**
   "Estamos com condições especiais" afasta. "Notei que você começou a fase X e parou; como está se sentindo?" aproxima. A diferença é personalização com base no histórico.

4. **Reabordar é cuidado ativo**
   Profissional de saúde responsável acompanha quem iniciou um cuidado. Chamar de volta quem precisa de continuidade é ético — desde que respeite a vontade e os dados do paciente.

5. **Remarcar não basta**
   Se nada mudar depois do retorno, o paciente some de novo. É preciso nutrir o vínculo com lembretes, acompanhamento e atenção ao pós-consulta.

6. **O que é medido vira hábito**
   Taxa de retorno e faturamento recuperado transformam uma ação pontual em rotina mensal — e mostram para a equipe o valor do trabalho.

TESE CENTRAL

A diferença entre um consultório ocupado e um consultório saudável está em quanto ele cuida de quem já passou por lá. Reativar é a forma mais barata, rápida e ética de crescer.

O MÉTODO

Método RESGATE

RESGATE são sete passos que vão do levantamento da base até a retenção de longo prazo. Os quatro primeiros acontecem antes de qualquer mensagem ser enviada.

R — **Radiografia da base**
Liste quem sumiu, parou ou deveria estar em acompanhamento.

E — **Entenda o motivo**
Levante hipóteses reais sobre o afastamento.

S — **Segmente por temperatura**
Priorize quem tem mais chance e mais necessidade.

G — **Gere a proposta certa**
O que esse paciente precisa agora?

A — **Aborde com roteiro**
Canal, pessoa e tom certos.

T — **Trilhe o retorno**
Acompanhe quem respondeu até a consulta acontecer.

E — **Eternize o vínculo**
Relacionamento contínuo para ninguém sumir de novo.

Regra de ouro: cada etapa pressupõe a anterior resolvida. Pular etapas é a forma mais rápida de concluir que “isso não funciona na minha área”.

R

ETAPA 1 DE 7

Radiografia da base

Objetivo: criar a lista de reativação a partir do prontuário e da agenda.

RACIOCÍNIO

Sem uma lista concreta, reativação vira intenção. A radiografia separa os inativos em grupos que exigem abordagens diferentes e revela, muitas vezes pela primeira vez, o tamanho do potencial parado na base.

COMO APLICAR

1. Exporte do sistema (ou levante manualmente) os pacientes dos últimos 12 a 24 meses.
2. Grupo 1 — **Primeira consulta sem retorno:** vieram uma vez e não voltaram.
3. Grupo 2 — **Tratamento interrompido:** iniciaram um plano e pararam no meio.
4. Grupo 3 — **Acompanhamento vencido:** deveriam ter voltado para revisão e não voltaram.
5. Grupo 4 — **Orçamento não fechado:** receberam proposta e não iniciaram.
6. Registre em uma planilha: nome, contato, data da última visita, grupo, serviço e observações do prontuário.

Planilha de radiografia

Paciente	Última visita	Grupo	Serviço / fase	Pista do prontuário
[nome]	[data]	2 — Interrompido	[tratamento · fase]	[ex.: relatou dificuldade financeira]

Erro comum: tentar abordar a base inteira de uma vez com a mesma mensagem. Isso vira disparo em massa — e disparo em massa parece spam.

E

ETAPA 2 DE 7

Entenda o motivo

Objetivo: entender por que cada perfil se afastou antes de decidir o que oferecer.

RACIOCÍNIO

A mesma mensagem não serve para quem parou por medo e para quem parou por achar que já estava bom. O prontuário, as anotações da recepção e o histórico de conversas costumam mostrar o motivo. Entender a causa é o que transforma a reabordagem de insistência em ajuda.

COMO APLICAR

1. Leia as anotações de cada paciente prioritário e classifique a causa provável:
2. **Medo:** de dor, de procedimento, de diagnóstico, de efeitos colaterais.
3. **Falta de orientação:** não entendeu a importância da continuidade ou os próximos passos.
4. **Custo:** dificuldade financeira, prioridade de outros gastos.
5. **Sensação de alta:** melhorou e achou que não precisava mais.
6. Escolha 3 perfis representativos e escreva uma hipótese para cada um antes de qualquer contato.

Causa → resposta

Causa	O que o paciente precisa ouvir
Medo	Acolhimento, explicação do processo, segurança
Falta de orientação	Clareza sobre por que continuar e o que acontece se parar
Custo	Opções de etapas, priorização e formas de pagamento
Sensação de alta	Importância da consolidação e da prevenção

Erro comum: assumir que todo mundo parou por preço e já oferecer desconto. Além de reduzir margem, isso ignora o verdadeiro motivo — e o paciente continua sem voltar.

S

ETAPA 3 DE 7

Segmente por temperatura

Objetivo: ordenar a lista para começar por quem tem maior probabilidade de retorno e maior benefício clínico.

RACIOCÍNIO

Tempo de equipe é limitado. Começar pelos pacientes “quentes” gera resultados rápidos, motiva a equipe e financia o resto do processo. A temperatura combina tempo desde o último contato, estágio do tratamento e o vínculo que o paciente tinha com a clínica.

COMO APLICAR

1. **Quentes:** afastados há menos de 3 meses ou com tratamento interrompido no meio.
2. **Mornos:** afastados entre 3 e 12 meses, com bom vínculo anterior.
3. **Frios:** afastados há mais de 12 meses ou com pouca interação.
4. Dentro de cada temperatura, priorize quem tem maior necessidade clínica de continuidade.
5. Defina uma meta semanal de contatos por temperatura (ex.: 15 quentes, 10 mornos, 5 frios).

Erro comum: começar pelos frios porque “são muitos”. Os resultados demoram, a equipe desanima e o processo morre antes de chegar aos quentes.

G

ETAPA 4 DE 7

Gere a proposta certa

Objetivo: definir, para cada segmento, uma proposta de retorno personalizada e clinicamente coerente.

RACIOCÍNIO

Antes de escrever a mensagem, responda: o que essa pessoa precisa neste momento? Um retorno clínico? Uma revisão? A continuidade da fase em que parou? Um programa de acompanhamento? Evite empurrar qualquer coisa. A proposta nasce do histórico — e é isso que diferencia cuidado ativo de venda.

COMO APLICAR

1. **Primeira consulta sem retorno:** convite para revisão do plano e esclarecimento de dúvidas.
2. **Tratamento interrompido:** retomada da fase em que parou, com reavaliação.
3. **Acompanhamento vencido:** consulta de revisão no intervalo recomendado.
4. **Orçamento não fechado:** nova conversa sobre prioridades, etapas e formas de pagamento.
5. **Pacientes esporádicos:** programa de acompanhamento com consultas regulares e calendário organizado.
6. Se oferecer qualquer condição comercial, verifique antes as regras do seu conselho profissional.

> **Erro comum:** usar a mesma oferta para todos os grupos. Proposta igual para situações diferentes é exatamente o que faz a reabordagem parecer venda.

A

ETAPA 5 DE 7

Aborde com roteiro

Objetivo: retomar o contato com empatia, clareza e ética, usando roteiros adaptáveis.

RACIOCÍNIO

O tom faz toda a diferença. A mesma informação pode soar como cuidado ou como cobrança. Por isso o método define três decisões antes do contato: o canal (WhatsApp, ligação ou e-mail), quem fala (profissional, secretária ou CRC) e o roteiro. Perguntas abertas são essenciais: elas revelam o que impediu o retorno e permitem resolver o obstáculo real.

COMO APLICAR

1. **Canal:** WhatsApp para a maioria; ligação para tratamentos interrompidos de maior complexidade; e-mail como complemento.
2. **Quem fala:** o profissional para casos clínicos sensíveis (um áudio curto dele tem enorme impacto); a CRC para revisões e orçamentos.
3. Use perguntas abertas: “O que seria necessário para retomarmos?”, “Como você está se sentindo?”.
4. Ouça a resposta e resolva o que impede o retorno: preço, forma de pagamento, tempo, medo ou falta de entendimento.
5. Ofereça duas opções concretas de horário, não um “quando você puder”.
6. Respeite quem não quiser retornar: agradeça e registre a preferência (LGPD).

> **Erro comum:** mandar mensagem genérica com emojis de festa para quem interrompeu um tratamento por medo. O roteiro precisa combinar com a causa do afastamento.

T

ETAPA 6 DE 7

Trilhe o retorno

Objetivo: garantir que o interesse se transforme em retorno efetivo, sem perder ninguém no caminho.

RACIOCÍNIO

Resposta positiva não é retorno. Entre o “quero voltar” e a consulta, existem esquecimentos, imprevistos e dúvidas. A trilha organiza esse caminho com etapas simples e registra o status de cada paciente.

COMO APLICAR

1. Classifique cada contato: sem resposta / respondeu / agendou / compareceu / retomou tratamento / não quer retornar.
2. Sem resposta: nova tentativa em 3 a 5 dias, por outro canal ou com outra abordagem.
3. Agendou: confirmação na véspera com mensagem personalizada.
4. Compareceu: o profissional reforça a continuidade e agenda o próximo passo antes de o paciente sair.
5. Atualize a planilha semanalmente.

Erro comum: comemorar o agendamento e esquecer a confirmação. Paciente reativado tem histórico de afastamento — e precisa de um cuidado extra para comparecer.

E

ETAPA 7 DE 7

Eternize o vínculo

Objetivo: nutrir o relacionamento depois do retorno e medir o impacto da reativação.

RACIOCÍNIO

Remarcar resolve o hoje; relacionamento resolve o amanhã. Lembretes, acompanhamento simples e atenção ao pós-consulta reduzem novos afastamentos. E os números — percentual de retorno e faturamento recuperado — transformam o resgate em rotina mensal.

COMO APLICAR

1. Crie um calendário de relacionamento: mensagem pós-consulta (48 h), lembrete de retorno, data de aniversário, conteúdo educativo periódico.
2. Ofereça programas de acompanhamento para quem precisa de cuidado contínuo.
3. Peça avaliação no Google aos pacientes reativados satisfeitos.
4. Meça mensalmente: % de pacientes reabordados que retornam e faturamento gerado por eles.
5. Repita o ciclo RESGATE todo mês com novos inativos.

Indicadores do resgate

- **Taxa de resposta** = responderam ÷ reabordados
- **Taxa de retorno** = compareceram ÷ reabordados
- **Faturamento recuperado** = soma do faturamento de pacientes reativados no mês
- **Retenção em 90 dias** = continuaram ativos ÷ reativados

Erro comum: fazer um “mutirão de reativação” uma vez por ano. Resgate funciona como hábito mensal, não como campanha.

ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

Primeiro ciclo de resgate em 30 dias

Um ciclo completo cabe em um mês. A partir do segundo mês, o processo vira rotina e leva poucas horas por semana.

SEMANA 1

Mapear e entender

- Radiografia da base em 4 grupos
- Leitura do prontuário dos prioritários
- Hipóteses de causa para 3 perfis
- Segmentação quentes / mornos / frios

Entregável: Lista de reativação priorizada

SEMANA 2

Propor e abordar

- Proposta por grupo definida
- Roteiros adaptados e aprovados
- Definição de canal e de quem fala
- Primeiros contatos com os quentes

Entregável: Primeira rodada de contatos feita

SEMANAS 3–4

Trilhar e medir

- Segunda tentativa para quem não respondeu
- Confirmações e retornos acontecendo
- Calendário de relacionamento ativo
- Primeira leitura dos indicadores

Entregável: Relatório do ciclo e meta do próximo mês

APLICABILIDADE

Como aplicar na sua realidade

Por perfil de clínica

Perfil	Como adaptar
Consultório solo	O próprio profissional grava áudios curtos para os casos mais sensíveis; a secretária executa o restante com os roteiros.
Odontologia	Orçamentos não fechados e manutenções vencidas (limpeza, revisão de aparelho, controle de implante) costumam ser os grupos mais rentáveis.
Dermatologia e estética	Tratamentos em sessões interrompidos e protocolos de manutenção têm alto potencial. Cuidado com ofertas que conflitem com as regras de publicidade.
Especialidades clínicas e crônicas	Acompanhamento vencido é o principal grupo — e reabordar aqui tem também um forte componente de segurança do paciente.
Fisioterapia, nutrição e psicologia	Sensação de alta é a causa mais comum. Fale de consolidação, prevenção e manutenção dos resultados.

Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
Profissional de saúde	Valida as propostas por grupo, grava áudios para casos sensíveis e reforça a continuidade no retorno.
Secretária / CRC	Faz a radiografia, executa os contatos, trilha os retornos e atualiza a planilha.
Gestor(a)	Define metas mensais, acompanha indicadores e garante horário protegido para o resgate.

Indicadores que provam que está funcionando

Indicador	O que responde	Como medir
Taxa de retorno	Quantos reabordados voltaram?	Compareceram ÷ reabordados
Faturamento recuperado	Quanto a reativação gerou?	Soma mensal dos reativados
Retenção em 90 dias	Eles ficaram ou sumiram de novo?	Ativos em 90 dias ÷ reativados
Inativos novos por mês	Estamos prevenindo novos sumiços?	Novos pacientes sem retorno no mês

MODELOS PRONTOS

Copie, adapte e use hoje

Troque apenas o que está entre colchetes. Ajuste o tom ao seu público — e valide sempre com as regras do seu conselho profissional.

Reabordagem simples (orçamento ou primeira consulta)

"Olá, [nome]! Aqui é a [nome], da [clínica]. Há [x] meses você esteve conosco para conversar com [Dr(a). nome] sobre [tratamento]. Pelo que vi aqui, você ainda não iniciou — é isso mesmo? O que seria necessário para darmos esse passo juntos? Tenho [dia] às [hora] ou [dia] às [hora] disponíveis. Qual fica melhor para você?"

Por que funciona: a pergunta aberta "o que seria necessário" revela a objeção real (preço, forma de pagamento, tempo, dúvida). O objetivo é resolver o que impede o retorno.

Tratamento interrompido

"Olá, [nome]! Aqui é a [nome], da [clínica]. Notamos que você iniciou o seu tratamento com [Dr(a). nome], mas não deu continuidade. Como você está se sentindo? Há algo em que possamos ajudar? Queremos garantir que você alcance o melhor cuidado possível. Temos horário no dia [data] para retomarmos de onde paramos — como seria para você?"

Por que funciona: abre com cuidado, não com cobrança, e propõe retomar exatamente do ponto em que o paciente parou.

Paciente esporádico → programa de acompanhamento

"Olá, [nome]! Aqui é a [nome], da [clínica]. Notei que suas consultas têm ficado mais espaçadas e queria te fazer um convite: organizamos um acompanhamento ao longo do ano, com consultas em intervalos regulares — você não precisa se preocupar em lembrar de agendar e mantém o cuidado em dia. Posso te explicar como funciona ou já agendamos a próxima consulta?"

Por que funciona: transforma visitas soltas em continuidade organizada, com benefício claro para o paciente.

Aniversário (relacionamento, sem desconto em procedimento)

“Feliz aniversário, [nome]! 🎉 Toda a equipe da [clínica] deseja um novo ano de muita saúde e realizações. Obrigada por confiar no nosso cuidado. Se quiser aproveitar para colocar sua revisão em dia, é só responder esta mensagem que a gente organiza tudo para você. 💙”

Por que funciona: mantém o vínculo sem oferecer desconto em procedimento — prática que pode conflitar com regras de publicidade de alguns conselhos.

CONEXÃO COM A COLEÇÃO

Leia em seguida

VOLUME 04 · COLEÇÃO ACELERADOR DE CLÍNICAS

Recepção que Fatura

Converta interessados em pacientes

Como ele potencializa o que você acabou de aprender

O Resgate de Ouro define **quem** reabordar e **o que** propor. O Volume 04, **Recepção que Fatura**, dá à equipe as ferramentas para executar isso com consistência: CRM com estágios, cadência de acompanhamento, técnicas de conexão, contorno de objeções e protocolo anti-falta.

Na prática, o paciente reativado entra no funil da Recepção que Fatura como um interessado "morno": já conhece a clínica, mas precisa de conexão, clareza e acompanhamento para voltar. Quando a CRC domina o Método FECHA, a taxa de retorno do resgate sobe — e quem não volta agora continua sendo acompanhado com valor.

COMBINAÇÕES PRÁTICAS

- → Cadastre cada paciente da radiografia no CRM, na estação "Contatado" ou "Engajado".
- → Use a técnica do aliado (Etapa A do FECHA) para responder às objeções da reabordagem.
- → Aplique o protocolo anti-falta do Volume 04 em todo retorno agendado pelo resgate.

> **Também combina com o Volume 02 · Referência na Cidade:** pacientes reativados e satisfeitos são a melhor fonte de avaliações no Google — combustível direto para a Etapa S do Referência na Cidade.

Onde este volume entra na jornada da clínica

A coleção segue a ordem em que um paciente descobre, decide e volta. Cada volume resolve um elo — e conversa com os outros.

01	02	03	04	05	06
DNA Comercial	**Referência na Cidade**	**Vitrine Magnética**	**Recepção que Fatura**	**Consulta Assinatura**	**Resgate de Ouro**
Defina o que vender e como explicar	Seja encontrado no Google, nas IAs e na imprensa	Instagram que vende a consulta	Converta interessados em pacientes	Entregue uma consulta de alto valor	Reative quem já confiou em você

PARA TERMINAR

O que separa quem executa de quem só lê

O Método RESGATE é sobre olhar com estratégia para o que a clínica já tem. Cada nome no prontuário é alguém que um dia confiou em você — e muitos deles ainda precisam do seu cuidado.

Comece pequeno: dez pacientes quentes nesta semana. Leia o prontuário, entenda o motivo, escreva uma mensagem que só aquela pessoa poderia receber. Os primeiros retornos vão mostrar o caminho.

Antes de correr atrás de quem ainda não te conhece, cuide de quem já te escolheu.

Nota ética e legal: este material é educativo sobre gestão, comunicação e vendas em saúde. Não constitui orientação clínica nem parecer jurídico. Regras de publicidade variam por conselho (CFM, CFO, CFN, COFFITO e outros) e mudam com o tempo — confirme cada peça antes de publicar e trate dados de pacientes conforme a LGPD.

Acelerador de Clínicas

Estratégia, processo e vendas para clínicas e consultórios que querem crescer com previsibilidade — e sem perder a essência do cuidado.

Quer implementar o Método RESGATE com acompanhamento?

Agende um diagnóstico da sua clínica: onde o faturamento está vazando, o que priorizar nos próximos 90 dias e qual volume da coleção aplicar primeiro.

aceleradordeclinicas.com.br

01 · DNA Comercial
02 · Referência na Cidade
03 · Vitrine Magnética
04 · Recepção que Fatura
05 · Consulta Assinatura
06 · Resgate de Ouro

© Acelerador de Clínicas · Coleção Acelerador de Clínicas · Volume 06 — Resgate de Ouro